

TEMA 9.64 • RESPIRATORIO

Rinitis No Alérgicas

PERFIL EUNACOM 1.04.1.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción a las Rinitis No Alérgicas

La **rinitis no alérgica** es un conjunto de cuadros clínicos caracterizados por inflamación de la mucosa nasal que no es mediada por mecanismos de hipersensibilidad tipo I (IgE). Es fundamental entender que este es un **diagnóstico de descarte**; antes de catalogar a un paciente en este grupo, se debe haber descartado una **Rinitis Alérgica** mediante la clínica y pruebas complementarias.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, la clave de las rinitis no alérgicas es que presentan un **Prick Test (test cutáneo) negativo** y una IgE específica negativa, a pesar de tener síntomas muy similares a la alergia.

Clasificación y Clínica Específica

Existen varios subtipos de rinitis no alérgica que se diferencian por sus desencadenantes y fisiopatología:

1. Rinitis Vasomotora

Es la forma más común de rinitis no alérgica. Se produce por un desequilibrio del sistema autonómico en la mucosa nasal. - **Desencadenantes:** Cambios bruscos de temperatura, ejercicio físico, olores fuertes (perfumes, productos de limpieza), humo de cigarrillo o cambios en la humedad. - **Clínica:** Congestión nasal y rinorrea acuosa que aparece rápidamente ante los estímulos mencionados.

2. Rinitis Gustatoria

Es una variante de la rinitis vasomotora. - **Desencadenantes:** Ingesta de alimentos calientes (sopas) o muy condimentados (ají, pimienta). - **Clínica:** Rinorrea acuosa profusa exclusivamente durante la alimentación.

3. Síndrome de NARES (Rinitis No Alérgica con Eosinofilia)

- **Características:** Clínicamente es indistinguible de una rinitis alérgica severa. - **Diagnóstico:** Presenta **eosinófilos en el frotis nasal**, pero el **Prick Test es negativo**. - **Tratamiento:** Responde excelentemente a los corticoides nasales.

4. Rinitis Hormonal

Asociada a cambios en los niveles de estrógenos. - **Contexto:** Principalmente en el **embarazo** (especialmente en el tercer trimestre) o por uso de anticonceptivos orales. - **Clínica:** Congestión nasal persistente. - **Resolución:** En el caso del embarazo, el cuadro desaparece tras el parto.

5. Rinitis Atrófica (Ozena)

Se produce por una atrofia de la mucosa y los cornetes, a menudo tras cirugías nasales agresivas (como turbinectomías extensas). - **Fisiopatología:** Las fosas nasales quedan demasiado amplias, el aire circula en exceso y reseca la mucosa, favoreciendo la colonización bacteriana. - **Clínica:** Formación de **costras verdosas de mal olor** (cacosmia) y sensación de obstrucción nasal a pesar de tener fosas amplias (paradoja nasal).

6. Rinitis Medicamentosa

Producida por el uso crónico de fármacos. - **Causa principal:** Abuso de **descongestionantes tópicos** (ej. Oximetazolina) por más de 5-7 días. - **Mecanismo:** Efecto rebote por desensibilización de los receptores alfa-adrenérgicos.

Diagnóstico y Manejo General

El diagnóstico es **clínico**, apoyado por la historia de exposición a desencadenantes y la negatividad de las pruebas alérgicas.

Tabla Comparativa de Manejo

TABLA 9.64.1: TIPO DE RINITIS VS TRATAMIENTO DE ELECCIÓN		
TIPO DE RINITIS	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN	OBSERVACIONES
Vasomotora	Antihistamínicos tópicos (Azelaстина)	Los antihistamínicos orales NO sirven.
Gustatoria	Bromuro de Ipratropio tópico	Se usa antes de las comidas.
NARES	Corticoides intranasales	Muy buena respuesta.
Hormonal	Lavados nasales / Parto	Evitar fármacos si es posible.
Atrófica	Lavados con suero / ATB tópicos	Cirugía en casos graves para estrechar la fosa.
Medicamentosa	Suspensión del fármaco + Corticoides	Educación al paciente sobre el efecto rebote.

NOTA CLÍNICA

¿Por qué Azelastina? A diferencia de los antihistamínicos orales que bloquean solo el receptor H1, los tópicos como la **Azelastina** tienen efectos antiinflamatorios locales adicionales que ayudan en la rinitis vasomotora.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El uso de descongestionantes tópicos (Oximetazolina) no debe superar los 5 días. Si se usan, es preferible combinarlos con corticoides nasales para mitigar el efecto rebote, aunque lo ideal es evitarlos como tratamiento de mantención.

Vestibulitis Nasal

La vestibulitis nasal no es una rinitis, sino una infección de la piel y estructuras del **vestíbulo nasal** (la entrada de la nariz).

- **Etiología:** Generalmente por **Staphylococcus aureus**.
- **Fisiopatología:** Se produce por una **foliculitis de las vibrisas** (los pelos nasales), a menudo secundaria a microtraumatismos (rascado, depilación de vellos nasales).
- **Clínica:**
 - - Eritema (enrojecimiento) en la punta de la nariz o entrada de las narinas.
 - - Dolor local intenso.
 - - Formación de costras mielicéricas.
- **Tratamiento:**
 - 1. **Tópico (Elección inicial):** Ungüento de **Mupirocina** o ácido fusídico.
 - 2. **Oral (Casos severos o mala respuesta):** Antibióticos con cobertura para *S. aureus* como Cloxacilina, Flucloxacilina, Cefadroxilo o Amoxicilina + Ácido Clavulánico.

EUNACOM CRITERIOS

La vestibulitis nasal es una infección en el "triángulo de la muerte" de la cara. Una complicación rara pero grave de las infecciones en esta zona es la **trombosis del seno cavernoso** por drenaje venoso retrógrado. Siempre tratar activamente.

Resumen de Perlas EUNACOM

- **Rinitis Vasomotora:** El paciente que estornuda o se tapa al salir al frío o entrar a un lugar con humo. Tratamiento: Azelastina tópica.
- **Rinorrea al comer sopa:** Rinitis gustatoria → Bromuro de Ipratropio (anticolinérgico que "seca" la nariz).
- **Costras con mal olor post-cirugía:** Rinitis atrófica (Ozena).
- **Embarazada con nariz tapada:** Rinitis hormonal. No requiere mayor estudio si es al final del embarazo.
- **Vestibulitis:** Infección por *S. aureus*, se trata con Mupirocina tópica.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Una mujer de 50 años consulta por rinorrea y obstrucción nasal persistente que empeora con los cambios de temperatura y al exponerse a humo de cigarrillo. No presenta prurito. Se realiza prick test que resulta negativo. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea más adecuado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Rinitis No Alérgicas. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Rinitis no alérgica es diagnóstico de descarte: requiere clínica compatible + prick test negativo
- Rinitis vasomotora: desencadenada por ejercicio, cambios de temperatura, olores; la más preguntada
- Antihistamínicos orales NO sirven en rinitis no alérgica; si sirven los antihistamínicos tópicos (azelastina)
- Corticoides tópicos nasales son efectivos tanto en alérgica como en no alérgica
- Ipratropio (anticolinérgico) útil cuando predomina la rinorrea en rinitis no alérgica
- NARES: idénticas a las alérgicas pero con prick test negativo; responden bien a corticoides nasales
- Rinitis hormonal: aparece al final del embarazo, se resuelve con el parto
- Rinitis atrófica (ozena): post-cirugía nasal, costras malolientes, mucosa atrófica; lavados nasales y antibióticos tópicos
- Rinitis farmacológica: abuso de descongestionantes tópicos (oximetazolina) con efecto rebote
- Vestibulitis nasal: foliculitis por *estafilococo aureo*; tratamiento con mupirocina tópica

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (RINITIS NO ALÉRGICAS)

PREGUNTA 1

Una mujer de 50 años consulta por rinorrea y obstrucción nasal persistente que empeora con los cambios de temperatura y al exponerse a humo de cigarrillo. No presenta prurito. Se realiza prick test que resulta negativo. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea más adecuado?

- A) Loratadina oral una vez al día
- B) Azelastina tópica nasal y/o corticoide tópico nasal
- C) Prednisona oral por 7 días
- D) Oximetazolina tópica nasal de uso continuo
- E) Inmunoterapia sublingual con alérgenos

PREGUNTA 2

Una embarazada de 34 semanas consulta por obstrucción nasal y rinorrea que inició hace 3 semanas. No tiene antecedentes de alergia ni atopía. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y cuando se espera la resolución?

- A) Rinitis alérgica estacional; se resolverá al terminar la primavera
- B) Sinusitis bacteriana aguda; requiere antibióticos
- C) Rinitis hormonal del embarazo; se resolverá con el parto
- D) Rinitis farmacológica; debe suspender descongestionantes
- E) Rinitis atrófica; requiere cirugía correctiva

PREGUNTA 3

Un paciente de 60 años consulta por costras nasales malolientes y obstrucción nasal desde hace varios meses. Tiene antecedente de cirugía nasal (septoplastia con turbinectomía) hace 2 años. Al examen se observan fosas nasales amplias con mucosa atrófica y costras de mal olor. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

- A) Sinusitis crónica bacteriana; amoxicilina-ácido clavulánico por 3 semanas
- B) Rinitis atrófica (ozena); lavados con suero fisiológico y antibióticos tópicos
- C) Vestibulitis nasal; mupirocina tópica
- D) Poliposis nasal; corticoides orales
- E) Rinitis farmacológica; suspender descongestionantes

RESUMEN: RINITIS NO ALERGICAS

Esta clase aborda las rinitis no alérgicas, que son un diagnóstico de descarte que requiere clínica compatible y prick test negativo. Las principales causas incluyen la rinitis vasomotora, las NARES (rinitis no alérgica con eosinofilia), la rinitis hormonal, la rinitis atrofica (ocena) y la rinitis farmacológica. La rinitis vasomotora se desencadena con ejercicio, cambios de temperatura, olores y humo de cigarrillo. La rinitis gustatoria es similar pero se asocia a condimentos y alimentos calientes. A diferencia de la rinitis alérgica, los antihistamínicos orales no sirven en las rinitis no alérgicas; en cambio, son efectivos los antihistamínicos tópicos (azelastina) y los corticoides tópicos. El ipratropio (anticolinérgico) es útil cuando predomina la rinorrea. Las NARES son idénticas a las alérgicas pero con prick test negativo y eosinofilia nasal, respondiendo muy bien a corticoides nasales. La rinitis hormonal se presenta al final del embarazo y se resuelve con el parto. La rinitis atrofica u ocena se presenta típicamente después de cirugía nasal, con fosas nasales amplias, costras malolientes y mucosa atrofica; se trata con lavados nasales, antibióticos tópicos y eventualmente cirugía reductora. La rinitis farmacológica se produce por abuso de descongestionantes tópicos (oximetazolina) con efecto rebote. Se menciona también la vestibulitis nasal como patología nasal externa causada por foliculitis por estafilococo aureo, que se trata con antibióticos tópicos (mupirocina) o sistémicos antiestafilococo.